

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE MIT LIEBE. MIT PASSION. MIT VERSTÄNDNIS.
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 14	Bezeichnung des Dokumentes: Verbandwechsel bei PEG	

Durchführende:

- Pflegefachkräfte (PFK)

Pflegeziel:

- Förderung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens
- Verhinderung einer Kontamination
- intakte Haut
- durch sorgfältige Pflege Funktionalität der Sonde erhalten

Indikation:

- frisch implantierte PEG
- bei älteren PEG 2 x wöchentlich bei komplikationslosem Verlauf als Schutzverband
- nach ärztlicher Anordnung

Kontraindikation:

- bei Ablehnung des Patienten

Vorbereitung:

- Hände waschen und Händedesinfektion
- Bewohner informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen zusammenstellen

Material:

- Händedesinfektionsmittel
- Hautdesinfektionsmittel
- unsterile/sterile Handschuhe
- 2 sterile Pinzetten (bei neu implantierten PEG)
- sterile Kompressen und Tupfer
- Pflaster
- Abwurfbeutel

Durchführung:

- Einsichtnahme in die Maßnahmeplanung
- Patienten bequem lagern
- Händedesinfektion
- unsterile Handschuhe anziehen
- Verband abnehmen und mit den Einmalhandschuhen werfen
- genaue Inspektion des Fisteleingangs auf Veränderungen des Fistelrandes, der umgebenden Haut und Absonderungen
- sterile Handschuhe anziehen
- Einsprühen des Fisteleingangs, Halteplatte und Sonde mit Desinfektionsspray und Durchführung der Händedesinfektion
- Reinigung des direkten Zugangs, Beseitigung möglicher Inkrustationen oder Wundsekrete (von innen nach außen mit einem Mulltupfer)
- Mobilisation der Sonde
- zwischen Haut und Halteplatten 2 Kompressen legen, die Halteplatte zurückschieben und mit einer Kompresse abdecken (non-touch)
- den Verband mit hautfreundlichem Pflaster fixieren

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN MIT SCHINDLER
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 14	Bezeichnung des Dokumentes: Verbandwechsel bei PEG	

Nachbereitung:

- Patienten bequem lagern
- Händedesinfektion
- Abfall entsorgen
- Desinfektion der Pinzetten
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen Zustands, der Haut, des seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL bzw. an die diensthabende PDL/PFK
- bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung

Festlegungen zur Wunddokumentation:

- Für jede Wunde ist 1 Wunddokumentationsbogen, chronische Wunden anzulegen.
- Die Dokumentation des Wundzustandes hat durch PFK in Zusammenarbeit mit der PFE bspw. nach dem Entfernen von avitalem Gewebe (Debridement), bei akuten Veränderungen, nach jedem Verbandwechsel bzw. mindestens alle 7 Tage zu erfolgen
- Zur Bewertung des Heilungsverlaufes bzw. Wundveränderungen können Fotos gefertigt werden. Der Bewohner hat hierzu eine Einwilligungserklärung nach § 201 a StGB zu unterzeichnen, wird das Fotografieren durch den Bewohner abgelehnt, ist die Wunde zu beschreiben.
- Wundfotos sind in monatlichen Abständen anzufertigen. Soweit möglich sind folgende Dinge zu beachten: vorher die Wunde spülen, gleiche Lichtverhältnisse, gleicher Abstand zum Objekt, Wunde soll mindestens 1/3 des Fotos einnehmen, gleicher Mitarbeiter, der fotografiert, Anlegen von Messmitteln ohne die Wunde zu verdecken, der Name des Bewohners und das Datum müssen erkennbar sein (Wundfotos ersetzen eine Beschreibung der Wunde nicht.).
- bei unauffälliger Wundsituation am Fisteleingang erfolgt keine Wunddokumentation

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA